INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA

Tipo do Documento	**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO**	Página 1/8	
Título do Documento	**MEDIDAS DE PRECAUÇÕES E ISOLAMENTOS**	Emissão: 31/05/2026 Versão: 4	Próxima revisão: 31/05/2027

1. CONCEITO: Prevenção a transmissão de microrganismos de um paciente, portador e ou doente, para outro, tanto de forma direta como indireta.

1.1 Responsável

SCIRAS

1.2 Responsáveis pela execução

É de responsabilidade de todos da equipe assistencial, incluindo os profissionais da equipe multidisciplinar.

1.3 Finalidades

- Promover medidas de precaução e isolamentos;
- Evitar transmissão cruzada de microrganismos;
- Evitar transmissão de microrganismos para o profissional de saude;
- Evitar deterioração clincia do paciente;
- Promover maior rotatitividade de leitos;

2. MATERIAIS

- EPI's
- Placas de precaução padronizadas pela anvisa
- Pastas plásticas pretas para capa de prontuário
- Plaquinhas sinalizadoras de precauçao para identificação do prontuário

3. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

PRECAUÇÃO PADRÃO

A Precaução padrão deve ser adotada no contato com todos os pacientes, independente da patologia ou condição clínica;

Higienizar as mãos com água e sabonete ou friccionar preparação alcóolica nos 5 momentos da higiene das mãos;

Higienizar as mãos antes de calçar as luvas e após retirá-las;

Utilizar luvas sempre que houver algum risco de contato com secreções, fluidos corporais, pele não íntegra e mucosas (o uso de luvas não substitui a higiene das mãos);

Usar máscaras, óculos e protetor facial em procedimentos que possam gerar respingos nas mucosas ocular, nasal e oral;

Utilizar avental quando houver risco de contaminação da roupa por fluídos corporais;

Ao retirar o avental, descarta-lo no local de atendimento do paciente. Higienizar as mãos após;

Não utilizar EPI fora da área de assistência;

Trocar avental e luvas a cada paciente atendido.

Identificar os resíduos de serviços de saúde do Grupo A pelo símbolo de risco biológico, com rótulo de fundo branco, desenho e contornos pretos, acrescido da expressão RESÍDUO INFECTANTE;

Descartar em lixeira de resíduo infectante os resíduos provenientes de pacientes em precaução por contato/gotícula/aerossóis;.

Descartar fluidos corporais no expurgo adotando as medidas de precaução padrão e com cuidado para não causar “respingos”.

Não retirar agulhas usadas das seringas descartáveis, não dobrá-las e nunca reencapá-las utilizando as duas mãos. O descarte desses materiais deve ser feito em caixas apropriadas e resistentes. Sempre respeitar o limite de 2/3 da capacidade de enchimento destes recipientes.

PRECAUÇÃO POR CONTATO

Sinalizar a porta do quarto com placa de precaução de contato e realizar a identificação no prontuário.

Internar o paciente em quarto privativo. Quando não for possível, realizar isolamento por coorte em um quarto com paciente que apresente infecção pelo mesmo microorganismo e mesma resistencia antimicrobiana, respeitando a distância de 1 metro entre os leitos.

Utilizar luvas e avental de manga longa descartáveis exclusivos para o atendimento ao paciente: usá-los no contato com o paciente, manipulação de cateteres e sondas, do circuito e do equipamento ventilatório e de outras superfícies próximas ao leito;
Colocar as luvas e o avental imediatamente antes do contato com o paciente ou as superfícies próximas a ele, dentro do quarto do paciente.
Retirar as luvas e o avental , logo após o uso, antes de deixar o quarto. Higienizando as mãos em seguida;
Descartar os EPIs em lixeira adequada ainda dentro do quarto/enfermaria do paciente;
Artigos e equipamentos devem ser de uso exclusivo do paciente;
Após o uso de artigos e equipamentos, limpá-los e desinfetá-los/esterilizá-los após cada uso e alta/transferência;
Para equipamentos não-críticos, quando não houver quantitativo para uso exclusivo, proceder com desinfecção a casa uso. Ex.: termômetro, glicosímetro;
O transporte do paciente deve ser evitado, porém, quando necessário, o profissional deverá usar luvas e avental descartáveis para o contato com o paciente, tendo cuidado em não tocar em superfícies com as mãos enluvadas;
Macas e cadeiras utilizadas no transporte, e locais onde o paciente teve contato, deverão sofrer desinfecção após o uso, de preferência com álcool 70% ou de acordo com as especificações dos materiais.
Em caso de transporte do paciente, na necessidade de exames, procedimentos, o local de destino deve ser informado acerca da precaução.
Disponibilizar banheiro de uso exclusivo ou cadeira sanitária para pacientes colonizados/infectados por MDR;
PRECAUÇÃO POR AEROSSÓIS
Isolar paciente de caso suspeito ou confirmado de infecção por agente transmitido por aerossóis, partículas que ficam suspensas no ar e que são eliminadas pela fala, tosse, espirros de pessoas infectadas (ex.: tuberculose pulmonar ou laríngea, varicela, sarampo);
Sinalizar a porta do quarto com placa de precaução para aerossóis e realizar a identificação no prontuário;
Internar o paciente em quarto privativo. Quando não houver disponibilidade, interná-lo em quarto com paciente que apresente infecção pelo mesmo microorganismo. A distância mínima entre dois pacientes ou entre pacientes e visitantes deve ser de um metro.
Manter as portas do quarto sempre fechadas;
A máscara N95 ou PFF2 é de uso obrigatório pelo profissional durante todo o tempo em que estiver no quarto e deverá ser retirada apenas ao sair do quarto;
O transporte do paciente deve ser evitado, porém, quando necessário, ele deve utilizar imprescindivelmente, máscara cirúrgica.
PRECAUÇÃO POR GOTÍCULAS
Sinalizar a porta do quarto com placa de precaução para gotículas e realizar a identificação no prontuário.
Internar o paciente em quarto privativo. Quando não houver disponibilidade, interná-lo em quarto com paciente que apresente infecção pelo mesmo microorganismo. A distância mínima entre dois pacientes ou entre pacientes e visitantes deve ser de um metro.

A circulação de ar e ventilação especiais não são necessárias.

A máscara cirúrgica é de uso obrigatório para todas as pessoas que tiverem acesso ao quarto; e pelo profissional e paciente quando for transportado, bem como o acompanhante.

O transporte do paciente deverá ser evitado, porém, quando necessário, ele deve utilizar máscara cirúrgica.

SEQUENCIA CORRETA DE PARAMENTAÇÃO E DESPARAMENTAÇÃO DE EPI´s

PARAMENTAÇÃO	DESPARAMENTAÇÃO
1. Higienizar as mãos	**Retirar as luvas**
2. Colocar avental ou capote (em procedimentos geradores de aerossóis, utilizar capote impermeável).	1. Higienizar as mãos
3. Colocar máscara cirúrgica ou N95 (a depender do tipo de precaução)	2. Retirar o avental tocando na parte interna
4. Colocar gorro, quando recomendado.	3. Retirar o gorro
5. Colocar óculos de proteção.	4. Retirar os óculos de proteção
6. Higienizar as mãos..	5. Higienizar as mãos
7. Calçar luvas.	6. Retirar a máscara
	7. Higienizar as mãos

MEDIDAS DE CONTROLE AMBIENTAL

LIMPEZA CONCORRENTE

Realizar limpeza diária, três vezes ao dia e sempre que necessário nos quartos de pacientes colonizados/infectados por MDR;

realizar limpeza de todas as superfícies horizontais, de mobiliários e equipamentos, portas e maçanetas, parapeitos de janelas, piso, instalações sanitárias, cama, criado-mudo, painel de gases, painel de comunicação, suporte de soro, mesa de refeição e outros mobiliários que podem ser utilizados durante a assistência prestada;

Definir os tipos de saneantes utilizados de acordo com o tipo de microrganismo;

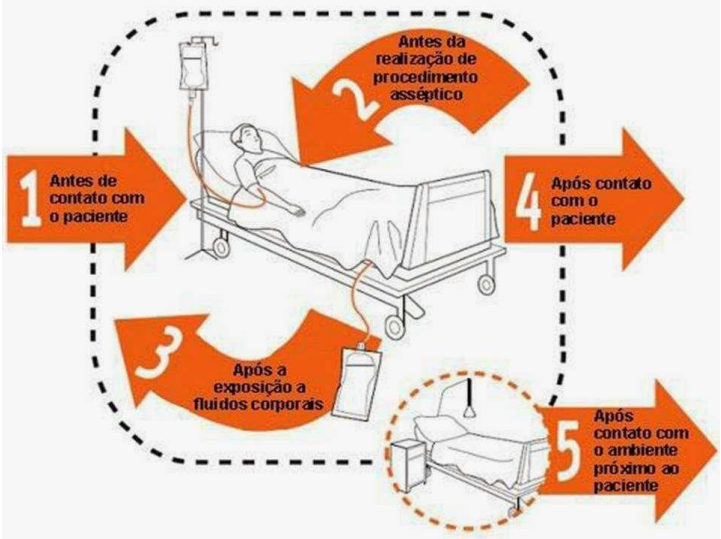
Esvaziar lixeiras

LIMPEZA TERMINAL

Realizar limpeza terminal a cada 15 dias e nas seguintes situações: alta hospitalar, transferências, óbitos e

ao suspender as precauções de contato, gotículas e aerossóis;
Definir os tipos de saneantes utilizados de acordo com o tipo de microrganismo;
Limpar, conforme POP institucional: paredes, pisos, teto, painel de gases, equipamentos, todos os mobiliários como camas, colchões, macas, mesas de cabeceira, mesas de refeição, armários, bancadas, janelas, vidros, portas, peitoris, divisórias, biombos, luminárias, lixeira, filtros e grades de ar-condicionado etc.
LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS
Utilizar equipamentos (oxímetros, esfigmomanômetros, termômetros etc.) exclusivos para o cuidado do paciente em isolamento;
Realizar a limpeza e desinfecção entre os usos quando os equipamentos para o cuidado do paciente em isolamento não forem exclusivos (oxímetros, esfigmomanômetros, termômetros).

4. ILUSTRAÇÕES / ANEXOS











5. REFERÊNCIAS

BRASIL. AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA (ANVISA). Prevenção de infecções por microrganismos multirresistentes em serviços de saúde – Série Segurança do Paciente e QualidadeemServiços de Saúde/Agência Nacional de Vigilancia Sanitária – Brasilia: Anvisa, 2021. 103p. Disponível em: https://pncq.org.br/wp-content/uploads/2021/03/manual-prevencao-de-multirresistentes7.pdf. Acesso em: 01 de Julho de 2023.

CAMPOS, A. P., SILVA, A. C. D. A., DUTRA, E. B. F., ROCHA, P. O., & FERNANDES, T. (2022). Impactos para o paciente da não adesão às medidas de precauções padrão e de isolamento no ambiente hospitalar. Disponivel em: https://repositorio.animaeducacao.com.br/handle/ANIMA/24717 . Acesso em: 01 de Julho de 2023.

Faria, L. B. G. D., Santos, C. T. B. D., Faustino, A. M., Oliveira, L. M. D. A. C., & Cruz, K. C. T. D. (2019). Conhecimento e adesão do enfermeiro às precauções padrão em unidades críticas. *Texto & Contexto-Enfermagem*, *28*. Disponivel em: https://www.scielo.br/j/tce/a/CyNfyfNJvgWCgKTGMkN6pwt/?lang=pt. Acesso em: 01 de julho de 2023.

Prevenção de infecções relacionadas à assistência à saúde: Precauções e isolamentos. Brasília-DF, 2025.

7. HISTORICO DE ELABORAÇAO/REVISAO		
VERSAO	**DATA**	**DESCRIÇAO DA AÇAO/ALTERAÇAO**
01	01/08/2023	Atualização e padronização
02	01/08/2024	Revisão
03	31/05/2025	Revisão
04	31/05/2026	Atualização

Versão 1 - Elaboração Nayanne Ingrid Farias Mota Guerra	Data: 01/07/2023
Versão 4 - Atualização Ana Carolina Gomes de Farias Julia Rodrigues Chaves **Revisão** Giulianna Carla **Validação** Matheus Soares **Registro, análise e revisão final** Giulianna Carla Nayanne Ingrid Farias Mota Guerra **Aprovação** Matheus Soares Sonia Delgado	Data: 31/05/2026